RECOMENDACIONES TRAZADORAS: INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN MENORES DE 18 AÑOS

Las recomendaciones trazadoras corresponden a un conjunto de intervenciones clínicas consideradas críticas para garantizar una atención segura, oportuna y basada en la evidencia en pacientes pediátricos con sospecha o diagnóstico de infección de vías urinarias (IVU). Estas recomendaciones fueron seleccionadas por su alto impacto sobre la oportunidad diagnóstica, el uso racional de antimicrobianos, la prevención de complicaciones renales y la estandarización del manejo clínico institucional.

Las recomendaciones diagnósticas fueron adoptadas de la Guía de Práctica Clínica del CENETEC (México, 2021), mientras que las recomendaciones terapéuticas fueron adaptadas a partir del consenso colombiano ACONEPE (2023) y del perfil local de resistencia bacteriana del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E., garantizando su aplicabilidad en el contexto institucional.

Documentos de referencia:

- Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de la infección de vías urinarias no complicada en menores de 18 años en el primer y segundo niveles de atención. CENETEC, México, 2021.

- Recomendaciones basadas en Guías de Práctica Clínica sobre diagnóstico, tratamiento y seguimiento de infección de tracto urinario en pacientes pediátricos en Colombia. Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica (ACONEPE), 2023.

Recomendación 1: Identificación de IVU

Se recomienda sospechar infección de vías urinarias en todo paciente menor de 18 años que presente manifestaciones clínicas compatibles según la edad, especialmente fiebre sin foco evidente, síntomas urinarios o signos sugestivos de compromiso del tracto urinario, con el fin de iniciar oportunamente el proceso diagnóstico.

Responsable

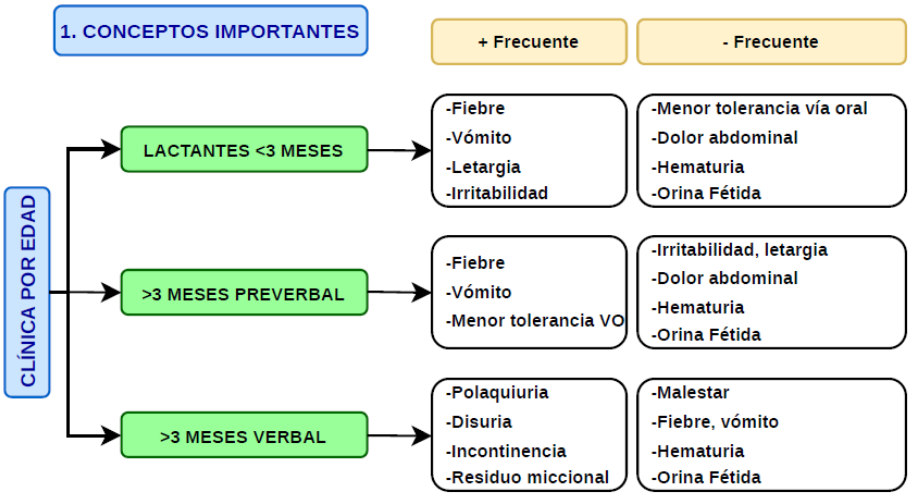
- Médico General
- Pediatra
- Médico de Urgencias

¿Cómo?

Debe registrarse en la historia clínica:

- Edad del paciente.

- Motivo de consulta.
- Signos y síntomas compatibles según edad:



Recomendación 2: Obtención muestra

Se recomienda obtener una muestra adecuada de orina antes del inicio del tratamiento antibiótico cuando exista sospecha clínica de infección urinaria.

Responsable

- Médico General
- Enfermería

¿Cómo?

Seleccionar el método de recolección de acuerdo con la edad:

- Micción espontánea
- Cateterismo vesical
- Punción suprapúbica
- Bolsa recolectora

Registrar:

- Método empleado
- Hora de toma
- Inicio del antibiótico posterior a la muestra

Recomendación 3: Diagnóstico

Se recomienda confirmar el diagnóstico mediante la integración de la clínica con uroanálisis y urocultivo, evitando tratar bacteriuria asintomática.

Responsable

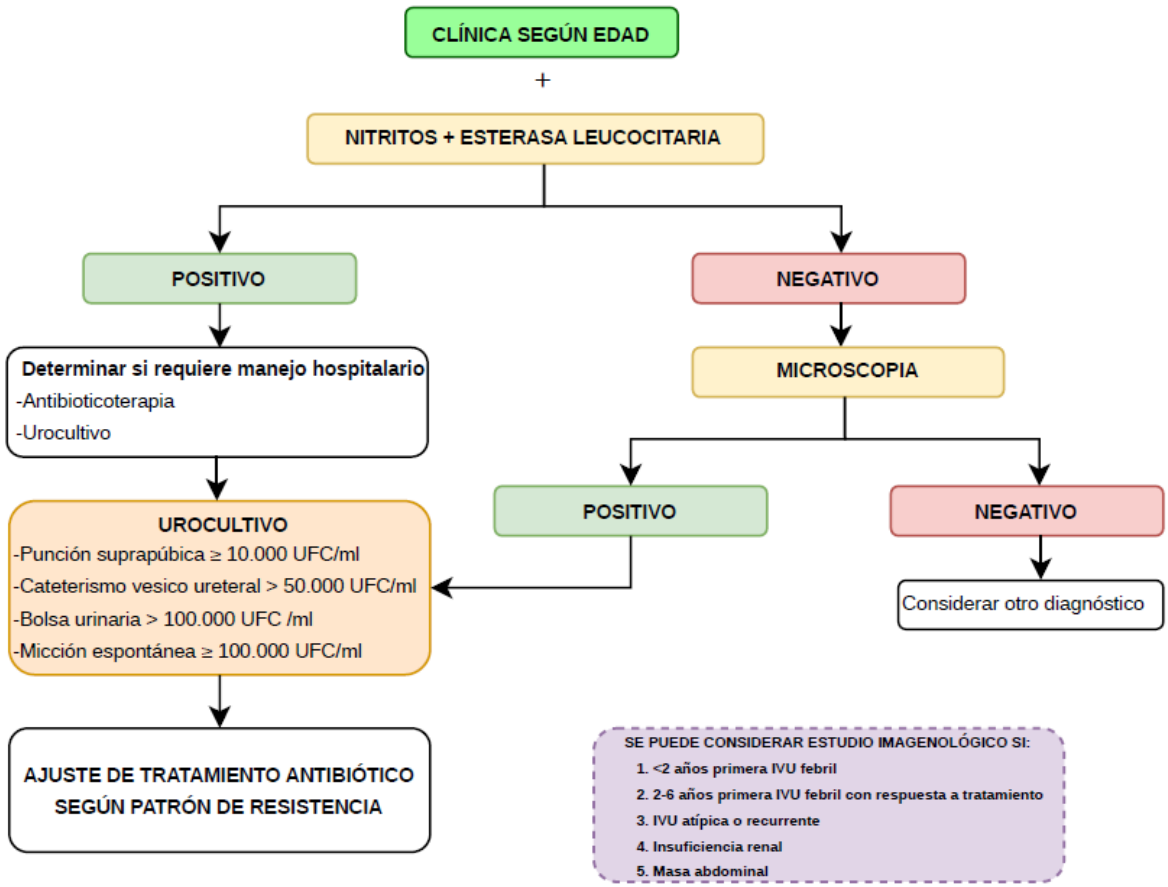
Médico tratante

¿Cómo?

Solicitar:

- Uroanálisis
- Urocultivo según indicación

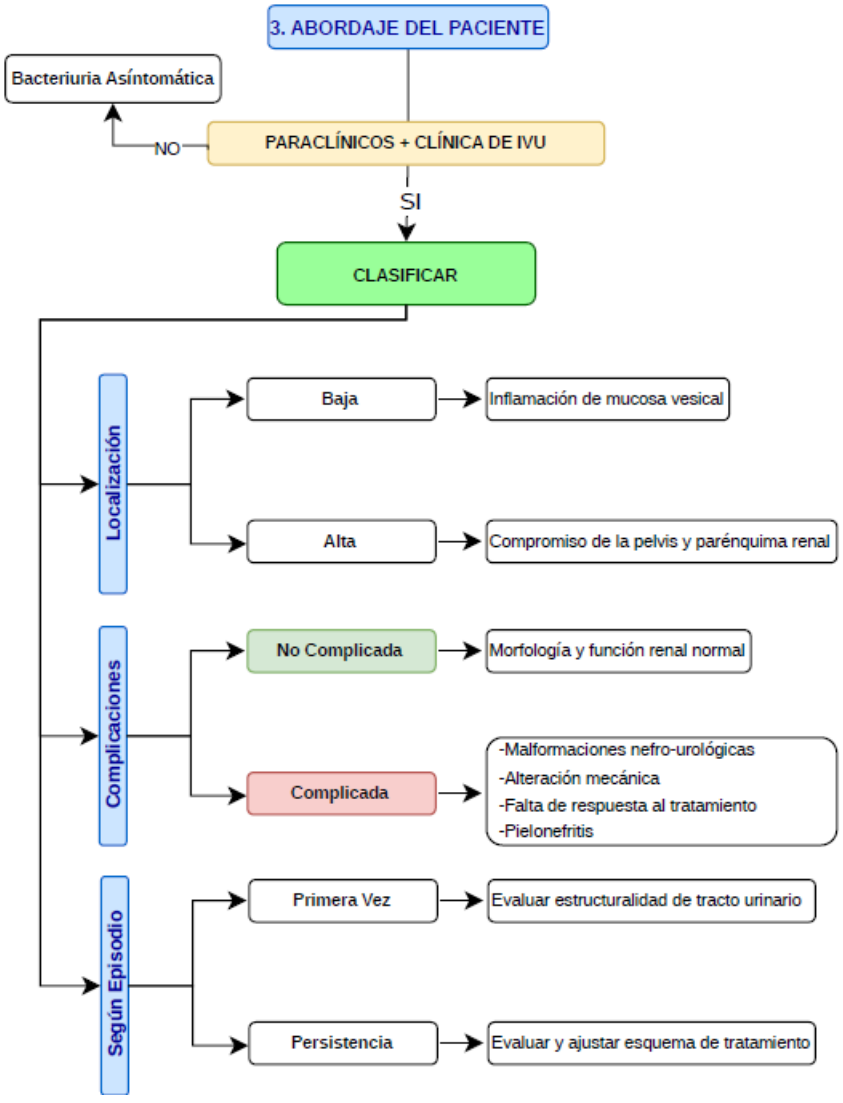
Registrar interpretación de resultados.



Recomendación 4: Clasificación clínica de la IVU

Clasificar y registrar:

- IVU baja
- Pielonefritis
- IVU complicada
- IVU recurrente
- Primera infección
- Persistencia



Nota: Para la institución, es indispensable que en la historia clínica se documente de manera explícita la clasificación de la infección de vías urinarias como complicada o no complicada, dado que esta definición orienta la conducta diagnóstica, terapéutica y el seguimiento del paciente.

Recomendación 5: Identificación de criterios de hospitalización

Registrar la presencia o ausencia de:

- Menores de tres meses
- Fiebre persistente
- Vómito
- Intolerancia oral
- Deshidratación
- Aspecto tóxico
- Alteración renal
- Alteraciones electrolíticas
- Mala perfusión

Si alguno está presente, indicar tratamiento hospitalario.

Recomendación 6: Selección del tratamiento empírico

4.1 TRATAMIENTO EMPÍRICO ORAL

CONDICIÓN	TRATAMIENTO 1° LÍNEA	DOSIS	TRATAMIENTO 2° LÍNEA	DOSIS
ITU baja	Cefalexina	75-100 mg/kg/día cada 6 horas	Amoxicilina-clavulanato	40-45 mg/kg/día cada 8-12 horas
ITU baja	TMP-SMX	8-10 mg/kg/día cada 12 horas	–	–
ITU baja	Nitrofurantoína	5-7 mg/kg/día cada 6 horas	–	–
ITU baja con factores de riesgo para microorganismos resistentes *	Amoxicilina-clavulanato	40-45 mg/kg/día cada 8-12 horas	TMP-SMX	8-10 mg/kg/día cada 12 horas
ITU alta	Cefalexina	75-100 mg/kg/día cada 6 horas	–	–
ITU alta	TMP-SMX	8-12 mg/kg/día cada 12 horas	–	–

4.2 TRATAMIENTO EMPÍRICO PARENTERAL				
CONDICIÓN	TRATAMIENTO 1° LÍNEA	DOSIS	TRATAMIENTO 2° LÍNEA	DOSIS
ITU baja	Cefazolina	100 mg/kg/día IV cada 6-8 horas	Amikacina *	15 mg/kg/dosis cada 24 horas Dosis máxima: 1000 mg/día
ITU baja			Gentamicina *	5-7 mg/kg/dosis cada 24 horas Dosis máxima: 2000 mg/día
ITU alta †	Cefazolina	100-150 mg/kg/día IV cada 8 horas Dosis usual: > 30 kg 750 mg IV cada 8 horas	Ceftriaxona	75-100 mg/kg/día cada 24 horas Dosis máxima en ITU: 2 g/día
ITU alta †			Amikacina *	15 mg/kg/dosis cada 24 horas
ITU Alta con factores de riesgo para microorganismos resistentes o por epidemiología local	Amikacina	15 mg/kg/dosis cada 24 horas	TMP-SMX	8-10 mg/kg/día cada 12 horas

Recomendación 8: Ajuste del tratamiento antibiótico

- Modificar el tratamiento una vez se disponga del antibiograma y urocultivo.
- Evitar mantener antibióticos de amplio espectro sin indicación.
- Registrar motivo del cambio.

Recomendación 9: Estudios imagenológicos

Solicitar únicamente cuando existan criterios establecidos:

- Menor de dos años con primera IVU febril
- IVU recurrente
- IVU atípica
- Masa abdominal en examen físico
- Insuficiencia renal
- Mala respuesta a tratamiento empírico instaurado

Recomendación 10: Educación al cuidador

Registrar educación sobre:

- Adherencia
- Hidratación
- Signos de alarma
- Consulta control pediatría al momento de egreso o decisión de manejo ambulatorio de IVU